



1. DATOS GENERALES:

NOMBRE: JERONIMO CALDERÓN PRENTT	H.C: 1066301336
EDAD: 6 Años	FECHA DE NACIMIENTO: 27/02/2019
ESCOLARIDAD: Transición	FECHA DE EVALUACIÓN: 15/05/2025
DIRECCION: Manzana 2 casa 6	CORREO: NA
EPS: Sanidad Policía	EVALUADOR: Jainer Guzmán Vega
ACOMPAÑANTE: Madre	CELULAR: 3128374495

MOTIVO DE CONSULTA

Madre refiere, le mandan evaluación neuropsicológica.

ENFERMEDAD ACTUAL

Paciente con cuadro de evolución desde los primeros años de vida caracterizado por agresividad a otras personas sin razón aparente, no se queda quieto, se levanta del puesto de manera permanente, no mide el peligro, expresa sus necesidades, está más abierto, aun le cuesta entablar una conversación, es capaz de responder algunas preguntas, toma las cosas sin consentimiento, no acepta los no, por ejemplo se terminó el tiempo de estar en televisión, de estar en el parque, no come fruta, no come verduras, se le debe dar de otra manera, buen rendimiento académico, aun no se reconoce en primera persona, aunque tiene buenas respuestas, en ocasiones presenta estereotipias motoras de mediana frecuencia. Esta diagnosticado con TEA, ha mostrado avances significativos a lo largo de los años.

ANTECEDENTES MEDICOS PERSONALES

ENFERMEDAD MEDICA: NO

Quirúrgicos: NO.

Tóxicos: NO.

Hospitalizaciones: NO.

Inmunizaciones: Si.

ANTECEDENTES MEDICOS FAMILIARES

Discapacidad intelectual: No reporta

Alcoholismo: No reporta

Drogadicción. No reporta

Epilepsia: No reporta

Autismo: No reporta

CONDICIÓN DEL PACIENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA

Paciente con adecuada presentación personal, alerta, inadecuada higiene postural, desorientada a lo y orientado auto psíquicamente, poca regulación, le cuesta inhibirse, distractivo, necesidad de apoyo y supervisión, buenas respuestas con apoyo, algunas dificultades en lenguaje.



PRUEBAS APLICADAS

Se realiza aplicación de evaluación neuropsicológica aplicando: **PRUEBA COGNITIVA COEFICIENTE INTELECTUAL (Wppsi 4)**, (Cubos, Semejanzas, información, Matrices, búsqueda de animales, reconocimiento, semejanzas, conceptos, cancelación, localización, rompecabezas.

Se realizó aplicación de **CUMANIM**, evaluando los cocientes verbales, no verbales y desarrollo global, lenguaje general: Psicomotricidad, lenguaje articulatorio, lenguaje expresivo, estructuración espacial, lenguaje comprensivo, viso percepción, memoria icónica, ritmo.



ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER
PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA- IV

TABLA DE RESULTADOS

EDAD 4:0 a 7:7

Subtest	Raw Score	Puntuaciones escalares Escala primaria					CIT
Información (I)	4	1					1
Semejanzas (S)	3	2					2
Cubos (C)	20		7				7
Rompecabezas (RO)	27		9				
Matrices (M)	8			4			4
Conceptos (CON)	11			7			
Localización (L)	4				2		
Reconocimiento (R)	14				7		7
Búsqueda de animales (BA)	24					7	7
Cancelación (CA) *	12					3	
Suma de puntuaciones escalares		3	16	11	9	10	28
Puntuaciones compuestas		49	88	74	67	73	63
		ICV	IVE	IRF	IMT	IVP	CIT
Clasificación <u>cuantitativa</u> de las puntuaciones compuestas		Muy Bajo	Medio-bajo	Bajo	Muy Bajo	Bajo	Muy Bajo



RANGO DE LA ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER

Rango percentil	Clasificación
130	Muy superior
120 - 129	Superior
110 - 119	Promedio alto
90 - 109	Promedio
80 - 89	Promedio bajo
70 - 79	Inferior
55 - 69	Discapacidad leve
40 - 54	Discapacidad moderada

La Capacidad Intelectual Total (CIT), es un indicador de la relación entre los cuatro índices en los cuales se encuentran agrupadas las 10 subpruebas. El paciente obtuvo un CIT de **63**, lo que lo ubica en 3 rangos por debajo del promedio para su edad y nivel escolar.

Comprensión verbal

El valor obtenido en ICV es de **49**, se clasifica como **discapacidad moderada**, estando en 4 rangos por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. Este indicador representa la capacidad para utilizar la información previamente aprendida, aptitudes específicas vinculadas a distintos ámbitos cognitivos que representan las habilidades intelectuales generales.

Visoespacial

El valor obtenido en IVE es de **88**, lo cual establece una capacidad **medio bajo**, estando un rango por debajo de lo esperado con respecto a su edad y escolaridad. Este indicador representa la capacidad para la inteligencia no verbal, entendida como la habilidad general para realizar manipulaciones mentales no-verbales, basándose en competencias de visualización y razonamiento espacial y la integración visomotora, competencias de atención y memoria.

Razonamiento fluido

El valor obtenido en IRF es de **74**, lo cual establece una capacidad **inferior**, estando dos rangos por debajo de lo esperado con respecto a su edad y escolaridad. Este índice mide la capacidad cognitiva innata del paciente para procesar nueva información.

Memoria de Trabajo

El valor obtenido en IMT es de **67**, se clasifica como **discapacidad leve**, estando en 3 rangos por debajo del promedio esperado con relación a su edad escolar y grupo etario. El índice de la memoria de trabajo (MT) es una medida de la memoria a corto plazo reflejando la capacidad para retener temporalmente en la memoria cierta información, trabajar con ella y generar resultados, implicando razonamiento, concentración, control mental.

Velocidad de procesamiento

El valor obtenido en el IVP es de **73**, lo cual establece una capacidad **inferior**, estando dos rangos por debajo de lo esperado con respecto a su edad y escolaridad. Este indicador representa la capacidad en la relación entre tiempo y tarea, capacidad de discriminación, de focalización de la atención y selección de estímulos visuales. Se encuentra capacidad para aparear información simple y para reconocer visualmente información en un periodo de tiempo determinado.

CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLOGICA INFANTIL: CUMANIN

RANGO DE LA ESCALA CUMANIN

Rango percentil	Clasificación
> 41	Rendimiento adecuado
20 - 40	Rendimiento bajo
< 20	Rendimiento muy bajo

CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLOGICA INFANTIL: CUMANIN			DESCRIPCIÓN CLINICA
ESCALAS PRINCIPALES	PD	PC	
PSICOMOTRICIDAD	4	2	ANORMAL
LENGUAJE ARTICULATORIO	0	3	ANORMAL
LENGUAJE EXPRESIVO	0	10	ANORMAL
LENGUAJE COMPRENSIVO	0	1	ANORMAL
ESTRUCTURA ESPACIAL	4	10	ANORMAL
VISOPERCEPCIÓN	7	10	ANORMAL
MEMORIA ICONICA	0	1	ANORMAL
RITMO	0	2	ANORMAL
PUNTAJE TOTAL	15		
DESARROLLO VERBAL	0	1	ANORMAL
DESARROLLO NO VERBAL	15	1	ANORMAL
DESARROLLO GLOBAL	15	1	ANORMAL
COCIENTE DE DESARROLLO	15	73	ANORMAL

Según aplicación de la prueba neuropsicológica y observación clínica se determina que existe un desarrollo anormal de la capacidad no verbal con un indicador de 1, lo cual significa que se encuentra dos rangos por debajo del promedio a lo esperado para su edad, grupo etario y escolaridad.

Las puntuaciones obtenidas en el desarrollo verbal establecen un indicador general de 1, lo cual es un signo de alarma para los procesos de comprensión y articulación.

El resultado en las pruebas establece un desarrollo general no esperado para la edad del cribado, el cual es de 73, obteniendo puntos débiles normativos en el desarrollo no verbal y verbal lo cual pueden generar problemas en el aprovechamiento académico y desarrollo intelectual.

DESARROLLO SENSOMOTOR:

Psicomotricidad: Evalúa diferentes aspectos de la motricidad fina y gruesa incluyendo la destreza digital, el equilibrio, la coordinación viso manual, reconocimiento corporal a partir de la estimulación digital.

El paciente obtuvo un percentil de, 2, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

Estructuración espacial: Evalúa diferentes aspectos relacionados con la orientación espacial y la comprensión de la posición y las nociones de izquierda a derecha, evalúa conceptos espaciales

básicos (delante, detrás, encima, debajo), grado de adquisición del esquema corporal (orientación auto psíquica o auto céntrica, orientación alopsíquica o alocéntrica), identificación del del espacio externo y orientarse correctamente hacia a él.

El paciente obtuvo un percentil de, 10, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

Viso percepción: Evalúa la capacidad de identificar correctamente las imágenes codificadas mediante el sistema visual y para reproducir esas imágenes mediante la motricidad grafo – manual. (sistema motor y visual).

El paciente obtuvo un percentil de, 10, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

Ritmo: Evalúa la capacidad para percibir, secuenciar y reproducir patrones auditivos no verbales mediante una tarea de imitación de ritmos.

El paciente obtuvo un percentil de, 2, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

MEMORIA Y APRENDIZAJE:

Memoria icónica o visual: Capacidad para mantener y recuperar información visual a corto plazo evalúa la curva de aprendizaje.

El paciente obtuvo un percentil de, 1, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

LENGUAJE:

Lenguaje articulatorio: Evalúa habilidades de pronunciación y articulación de diferentes fonemas producción del habla.

El paciente obtuvo un percentil de, 3, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

Lenguaje expresivo: Evalúa la estructura gramatical, evalúa recepción, comprensión y expresión del lenguaje oral, procesamiento audio fonológico y componente mnésico verbal.

El paciente obtuvo un percentil de, 10, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

Lenguaje comprensivo: Evalúa la interpretación basado en los componentes de atención, memoria y lenguaje.

El paciente obtuvo un percentil de, 1, lo que lo ubica en dos rangos por debajo del promedio esperado para su edad, grupo escolar y grupo etario.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE HABILIDADES ADAPTATIVAS

ÁREA	PUNTAJE	MEDIA	TOTAL	CONSIDERACIÓN
1) COMUNICACIÓN	2	10	21	ANORMAL
2) CUIDADO PERSONAL	6	20	22	ANORMAL
3) VIDA EN EL HOGAR.	12	5	10	ANORMAL
4) HABILIDADES SOCIALES.	2	20	44	ANORMAL
5) UTILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD	2	5	12	ANORMAL
6) AUTODIRECCIÓN.	7	5	12	NORMAL
7) SALUD Y SEGURIDAD.	2	7	17	ANORMAL
8) HABILIDADES ACADEMICAS - CONCEPTOS Y REPERTORIOS DE LECTO – ESCRITURA.	7	8	20	ANORMAL
9) CONCEPTOS Y REPERTORIOS MATEMATICOS.	7	10	30	ANORMAL
10) MOTRICIDAD FINA.	12	10	24	NORMAL
11) MOTRICIDAD GRUESA.	16	16	21	NORMAL
12) OCIO Y TIEMPO LIBRE.	1	10	16	ANORMAL
13) TRABAJO Y OCUPACIÓN.	2	5	23	ANORMAL



CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

Según la batería del **WIPPSI IV** de inteligencia, teniendo en cuenta que la media oscila entre 90 a 109, en donde el cribado obtuvo una puntuación o **CIT** de **63**, estableciendo para este momento evaluativo una **discapacidad general intelectual de gravedad leve**, ubicándolo en tres rangos por debajo de lo esperado al promedio en cuanto a su desarrollo general; puntuación que es equivalente a los resultados obtenidos en el **CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLOGICA INFANTIL: CUMANIN**, donde el paciente obtuvo una puntuación de **73**, con la diferencia que existe un rango de diferencia entre una y otra, lo cual obedece a que el CUMANIN evalúa aspectos relacionados con el desarrollo neuropsicológico, considerando que es posible que la afectación del comportamiento sea desadaptativa de forma considerable que este afectando la capacidad cognitiva.

Lo anterior establece la necesidad de adecuación y adaptación curricular en las aulas escolares, ya que esto puede limitar el aprovechamiento y desarrollo intelectual, de esta manera se busca crear estrategias que favorezcan la integración del menor, mejorar los procesos de atención sostenida, mantener una adecuada cintura escapular, mantenerse en la tarea, reducir la agitación motora, mejorar la escucha, las respuestas comprensivas y la expresión del lenguaje a partir de las técnicas basadas en la terapia ABA.

Las bajas puntuaciones en los indicadores de comprensión verbal, razonamiento visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, pueden generar dificultades en el procesamiento funcional de la información relacionada con la adquisición de nuevos aprendizajes y procesos de memoria a corto y largo plazo, el razonamiento complejo, el mantenimiento de la atención, la alteración de la conducta y comportamiento, le cuesta responder de forma efectiva y en el tiempo en que se espera que lo haga, siendo imprescindible la supervisión y monitoreo constante para realizar determinadas tareas, especialmente las que demandan mayor esfuerzo cognitivo y las relacionadas con la comprensión verbal compleja, es importante señalar que en muchas de la tarea la efectividad de la tarea depende de su capacidad motivacional o de intereses, lo cual explica las puntuaciones media bajas en razonamiento viso espacial, cinestésico, visual en comparación con actividades de contenido auditivo verbal donde debe definir conceptos abstractos.

Se observo diferencia de 39 puntos en cuanto a la comprensión verbal 49 y habilidades visoespaciales de 88, lo cual establece un mayor desarrollo del hemisferio derecho, en comparación con el hemisferio izquierdo, sin embargo, los dos procesos se encuentran por debajo del rango esperado, Esta diferencia es compatible con los resultados obtenidos en el **CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLOGICA INFANTIL: CUMANIN**, donde el paciente obtuvo una puntuación inferior en el desarrollo verbal (1) en comparación con el desarrollo no verbal (1), por lo que se recomienda la necesidad de estimulación como estrategia que permita un progreso equilibrado de los procesos cognoscitivos, teniendo mayores fortalezas en el aprendizaje cinestésico, visoespacial y motor.

Es importante citar que en lo referente al desarrollo verbal en el **CUESTIONARIO DE MADUREZ NEUROPSICOLOGICA INFANTIL: CUMANIN**, donde el paciente obtuvo una puntuación por debajo de lo esperado para un percentil de 1, lo cual sucede porque este cuestionario evalúa otros aspecto que no evalúa la prueba de inteligencia y deja ver algunas dificultades en la comprensión compleja, articulación de palabras específicas, expresión de



frase complejas y comprensión de lectura, cuestión a la cual se le debe hacer seguimiento e intervención a partir de la técnica de lenguaje aumentativo liderada por fonoaudiología.

Se observan respuestas por debajo de promedio en cuanto al procesamiento de la información con sus recursos innatos, del indicador de razonamiento fluido. 74, lo que dificulta en el paciente la capacidad de resolver nuevos problemas de forma inmediata, es decir, de forma instintiva y con destreza.

La memoria de trabajo, 67, se encuentran por debajo del promedio, con punto pudiendo generar dificultades en el manejo de la información a corto, plazo, en línea, siendo un punto débil normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

La velocidad de procesamiento, 73, se encuentran en un rango inferior, lo que puede establecer dificultades en las respuestas de forma rápida, efectiva y sin interferencia, punto fuerte normativo en el desarrollo académico y habilidades intelectuales.

Perfil del paciente:

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas y la observación clínica, se identifica el siguiente perfil neuropsicológico:

1) Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1 (anteriormente conocido como síndrome de Asperger), con una marcada afectación en el área del comportamiento, acompañado de **2) Discapacidad intelectual leve + Retraso en el lenguaje expresivo, receptivo y comprensivo**, presentando un mayor desarrollo en el componente manipulativo que en el verbal. A pesar de que ambos procesos se encuentran por debajo del promedio esperado para su edad, se ha observado que el canal manipulativo representa una vía más eficaz de aprendizaje para el menor.

Durante la evaluación, con apoyo, el paciente logró responder adecuadamente a preguntas relacionadas con el razonamiento visual y las praxias. Mostró una destacada facilidad para resolver rompecabezas y para manipular elementos electrónicos, como la computadora, en la cual ejecutó un número considerable de respuestas correctas.

El seguimiento de instrucciones simples (comandos de baja frecuencia) fue posible con ayuda. Sin embargo, aún presenta dificultades para regular sus impulsos y mostrar flexibilidad cognitiva. En ocasiones, su conducta es perseverativa: puede centrarse intensamente en una actividad que le interesa, resistiéndose a cambiar incluso cuando se le ofrecen alternativas relacionadas. Por ello, se recomienda apoyo constante con estrategias de contención conductual.

Por ejemplo, en la tarea de cubos, el paciente tuvo dificultades para seguir una secuencia verbal indicada por el evaluador, ya que interpretó la consigna desde una perspectiva distinta. No obstante, cuando se le presentó una imagen visual como modelo, logró realizar la tarea con éxito. Esto sugiere que posee una adecuada capacidad semántica, aunque presenta limitaciones en la comprensión verbal. Por lo tanto, se recomienda repetir las instrucciones varias veces y apoyarse en recursos visuales.



Durante la evaluación, se observaron momentos de **codependencia con la madre**, acompañados de **conductas agresivas**, algunas justificadas por la situación y otras no. Se recomienda la utilización de un muñeco o animal terapéutico, bajo la supervisión de un psicólogo clínico, para fomentar conductas proactivas y prosociales a través del contacto físico simbólico. En ningún caso se debe recurrir al castigo físico.

En situaciones de conducta inapropiada, se recomienda utilizar una firmeza verbal (elevar el tono) para indicar claramente que la conducta no es aceptable, retirando al menor de la actividad que le motiva (únicamente si dicha actividad resulta reforzante).

Se identificó **disprosodia y fuga de ideas** (responde con información no relacionada con la pregunta), además de una tendencia a levantarse repetidamente de su lugar de trabajo. Ante ello, se recomienda implementar la técnica de **intervalos fijos con razón fija**, estableciendo inicialmente una línea base del tiempo que permanece sentado, e incrementando progresivamente en intervalos de 5 segundos.

Se observaron **estereotipias verbales y motoras** de frecuencia media, especialmente en estados de emoción o angustia. El paciente presenta **baja tolerancia a la frustración** y dificultades en la interacción funcional con otras personas. Aún requiere trabajo en habilidades de **abstracción y definición de conceptos**.

Se recomienda continuar fortaleciendo la **estructura del yo**, utilizando el espejo y el reconocimiento corporal propio como herramienta, previo al abordaje de las relaciones interpersonales. Es fundamental trabajar el seguimiento de instrucciones mediante **encadenamiento conductual**, partiendo de sus intereses y motivaciones.

En cuanto a la alimentación, se recomienda abordar la **selectividad alimentaria** mediante el equipo de Terapia Ocupacional, integrando trabajo propioceptivo para la **hiperrespuesta sensorial**.

También es necesario continuar trabajando:

- El **contacto visual**
- La **atención focalizada y sostenida**, antes de introducir otras modalidades de atención, dado que presenta momentos de alta distracción o, por el contrario, de hiperfocalización (**hiperprosexia**).
- Se debe seguir trabajando la independencia como vestido, amarre de cordones, desplazamiento midiendo el peligro, conocer situaciones de peligro, responder de manera asertiva a partir del modelado, desensibilización sistemática, aproximación sucesivas, coste respuesta.

En términos generales, su comportamiento tiende a ser **desadaptativo**: muestra habilidades maduras para tareas visuales, pero inmadurez para autorregularse, inhibirse, centrarse, verificar sus acciones y modificar su comportamiento según el contexto. Esto afecta de manera significativa su funcionamiento personal, social, familiar y escolar.

COMPRESIÓN VERBAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN
VISOESPACIAL: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN
RAZONAMIENTO FLUIDO: PROMEDIO ALTO
MEMORIA DE TRABAJO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN



VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: NECESIDAD DE REHABILITACIÓN

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

F845 SÍNDROME DE ASPERGER (grado 1): Acompañado de:

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE GRAVEDAD LEVE O F701 RETRASO MENTAL LEVE: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO SIGNIFICATIVO, QUE REQUIERE ATENCION O TRATAMIENTO.

F808 RETRASO DEL DESARROLLO DEL HABLA Y LENGUAJE.

CIT DE 63, DISCAPACIDAD GENERAL INTELECTUAL DE GRAVEDAD LEVE, necesidad de apoyo, supervisión.

PLAN DE TRATAMIENTO

Consulta control por neuropsicología en tres meses.

Todos los rehabilitadores deberán revisar de forma detallada el perfil neuropsicológico del paciente como estrategia que permitirá seguir las indicaciones y recomendaciones dadas por el evaluador.

Rehabilitación desde fonoaudiología, que permita abordar a partir del lenguaje aumentativo de palabras (en word se enseñará a nominar elementos comunes de la vida diaria con las que interactúa el paciente, deberá primero nominar, luego mejorar la articulación, expresión, por ultimo se enseña a partir de memoria fotográfica (aprendizaje visual a largo plazo), el concepto. Se trabajará el seguimiento de instrucciones, comandos como con tu mano derecha tócate el ojo izquierdo, salta en dos pies y luego en un pies, etc, atención focalizada, sostenida, se abordará el reconocimiento del yo, partes del cuerpo en su propio cuerpo y en los otros, se hará contingencia si existe conducta agresiva.

Psicología deberá liderar la disminución de las estereotipias verbales y conductas agresivas midiendo la frecuencia e intensidad utilizando los programas de reforzamiento, a lo que se suma el seguimiento de comandos, contacto visual y estructuración yoica a partir de la técnica del ramillete del espejo.

Terapia ocupacional abordara la ingesta de alimentos, la propiocepción, atención focalizada y sostenida por intervalos de 10 segundos como base aumentando de 5 segundos apoyado en psicología para aplicar la técnica de razones fijas y variables, se debe abordar la hiperresponsividad y la conducta agresiva, así como el seguimiento de comandos.

Todos los rehabilitadores deben abordar la permanencia en el lugar de trabajo, enfocando las actividades desde las actividades de la vida diaria.



Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

Siente cerca al docente.

Verifique siempre si comprendido la consigna – pregunte varias veces.

Tenga en cuenta que algunas respuestas verbales pueden carecer de consistencia, realiza introducción si puede con imágenes de lo que se trata.

Integrarlo a las actividades, psico educar a los compañeros para lograr que apoyen la integración.

Colocarlo al lado del estudiante más sobresaliente para tareas específicas.

Divida las tareas que no le motivan en pequeños pasos, de esa manera será más fácil comprender lo que usted refiere o la intención de la clase o actividad.

Apoye las clases desde lo motor y visual, será más fácil para menor aprender.

Contemple los días más desadaptativos, no se lo tome personal.

Respete su estilo y ritmo de aprendizaje.

Tenga en cuenta que puede tardar más tiempo en desarrollar ciertas actividades.

Cree rutinas para cada día, visible donde pueda anticipar las actividades, agendas con fotos, pictogramas.

Apoye algunas clases con historietas, videos, cómics.

Explique la tarea por secuencia, paso a paso, apoyado en dibujos.

Elija un grupo de amigos que esté dispuesto a guiarle y a interactuar con él.

Utilice lenguaje claro, corto, apoye las respuestas, pregunte varias veces hasta que comprenda.

Prepárelo antes cuando existan cambios de planes, rutinas – organización, etc.



Tenga en cuenta y promueve los siguientes aspectos dentro y fuera del aula de clase.

- Reciprocidad social intensiva.
- Conversación recíproca intensiva.
- Iniciación social.
- Capacidad de adaptación y flexibilidad cognitiva al cambio.
- Emociones.
- Empatía.
- Comprensión y cognición social, Habilidades sociales.
- Intervención grupal, con el objetivo de reforzar las habilidades sociales, socio-comunicativas.
- Identificación y manejo de las emociones, resolución de conflictos con iguales, comprensión de las situaciones sociales y comportamiento asertivo

Recomendaciones para la casa

Incluya el uso de imágenes y pictograma para aumentar el lenguaje (vocabulario, reconocimiento de imágenes) y fomentar la comunicación.

Elabore horarios visuales por día de modo que su hijo sepa que va a hacer, reduciendo de esta forma la frustración.

Reúnase a jugar en grupos con su hijo a vaya a lugares donde hay más niños para trabajar la interacción.

Ayude a su hijo a resolver los problemas cuando este molesto, dándole ideas y posibilidad de soluciones “NO SE LOS RESUELVA”.

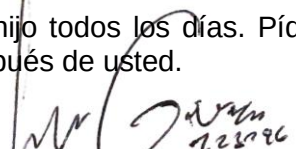
Hable sobre las emociones de su hijo.

Ayude a su hijo a identificar sentimientos y emociones en libros de cuento.

Fije reglas y límites para el niño y respételas.

Dele a su hijo instrucciones con 2 acciones, Ej. ve a tu cuarto tráeme las medias y los zapatos.

Léale a su hijo todos los días. Pídale que señale cosas en ilustraciones y que repita la palabra después de usted.


Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096

Firma U.S.B. - Medellín

Nombre del Profesional: Jainer Enrique Guzmán Vega

Especialidad: M. G Neuropsicología – Universidad de San Buenaventura de Medellín.

No. Tarjeta Profesional:123096